

Généralités : Sémantique médicale

Pr HLNS DEBBACHE

Objectifs pédagogiques

1. Compréhension et analyse des terminologies et concepts
2. Comprendre l'importance de la sémiologie médicale

Table des matières

1.Définitions.....	1
2.Pourquoi il y a-t-il des erreurs médicales ?.....	2
3.Symptômes et signes	2
4.Recueil des signes.....	3
5.Classification	3
6.Syndrome et maladie	4
7.Étiologie, pathogénie, physiopathologie.....	4
8.Classification des maladies :Nosologie (nosos, maladie)	4
9.Sémiologie quantitative	4
10.L'importance de la sémiologie.....	4
11.Comment apprendre la sémiologie ?.....	5
12.Élaboration du diagnostic	5
13.Communication non verbale	5
14.Dialogue avec le patient : 2 exigences :	5
Références bibliographiques	5

1.Définitions

Sémantique :nom féminin et adjectif didactique

1. nom féminin

Étude du sens, de la signification des signes, notamment dans le langage.

Synonymes :sémiologie

2. Adjectif :Qui concerne le sens, la signification.Analyse sémantique.

La sémiologie est la partie de la médecine qui étudie les signes des maladies (gr. sêméion, signe ; logos, discours) » - Dictionnaire Garnier Delamare.

La sémiologie médicale est la partie de la médecine qui étudie les signes (qui traduisent la lésion ou le trouble d'une fonction) que peut relever le médecin à l'examen clinique (signes physiques, signes fonctionnels et généraux) ou avec des examens complémentaires (imagerie, biologie), à partir desquels il dresse un tableau

clinique. Elle étudie également la manière de les relever (interrogatoire, examen physique, examens complémentaires) et de les présenter (rédaction d'une observation, regroupement en syndromes) afin de poser un diagnostic.

La sémiologie est la science des signes. Le terme sémiologie a été créé par Émile Littré et pour lui, il se rapportait à la médecine. Il a ensuite été repris et élargi par Ferdinand de Saussure, pour qui la sémiologie est « la science qui étudie la vie des signes au sein de la vie sociale ». Le terme sémiotique, inventé par Charles Sanders Peirce quelques années auparavant, recouvre la même idée et est utilisé le plus fréquemment en dehors de la France. Toute science étudiant des signes est une sémiologie. Le terme est donc utilisé dans plusieurs disciplines.

La sémiologie médicale est la base du raisonnement clinique. A chaque maladie correspond un certain nombre de signes qui vont nous permettre de reconnaître ces maladies.

En pratique clinique, la sémiologie repose sur l'examen clinique et les explorations complémentaires. On ne peut reconnaître le « pathologique » qu'en connaissant le « normal ».

L'examen clinique doit être centré sur le malade et non sur la maladie.

Santé et maladie :

La définition de la santé selon l'OMS est : « Bien être physique, mental et social » (OMS) .Les ruptures dans cet équilibre ≠ recours au corps médical. Un mal être social peut engendrer un mal être psychique qui peut lui-même engendrer un mal être physique.

Maladie = rupture de cette harmonie .Plusieurs causes :

- Agents extérieurs (bactéries, traumatismes, etc)
- Facteurs constitutionnels ou favorisants = génétiques, etc
- Facteurs précipitants (psycho-sociaux)

Médecin : Science, Conscience et Bon sens.

2.Pourquoi il y a-t-il des erreurs médicales ?

Parce que la plupart du temps le raisonnement clinique est faussé d'emblée car il ne s'appuie pas sur une analyse sémiologique très précise. On n'a pas toujours envie d'écouter l'histoire du patient, ses douleurs, ses souffrances. *La sémiologie c'est avant tout l'écoute*, et cela demande un effort. La sémiologie est basée sur l'étude des symptômes et des signes. *Elle est la base du diagnostic : Recueil des signes pour ensuite pouvoir les ranger afin d'identifier une maladie.*

3.Symptômes et signes

Symptômes = plaintes du malade (écouter, observer)

Les symptômes sont les manifestations pathologiques ressenties par le malade. Il y a une connotation personnelle, chacun a sa façon d'exprimer sa douleur. En effet, il ressent la douleur telle qu'il l'a déjà vécu, on est marqué par les douleurs que l'on a eu

Les symptômes sont :

- décrits (enfant ou adulte, importance+++du langage)
- ou « exprimés » (nourrisson, vieillard ou sujet dément... importance ++ de l'observation)

Signes reconnus , observés par le médecin selon :

- leur présentation
- la caractérisation des plaintes
- recherche orientée de certains symptômes que le patient ne présente pas nécessairement car il ne pense pas que cela est important (ex : céphalées depuis 48h et vomissements → méningites, autre signe photophobie)

– éventuellement des examens para-cliniques qui ne sont demandés qu'en fonction des données de l'interrogatoire.

4. Recueil des signes

Le recueil des signes se fait par deux biais :

- l'examen clinique qui se déroule en deux temps, successivement :
 - ❖ l'interrogatoire du patient ou de celui qui l'accompagne
 - ❖ l'examen physique, selon quatre modalités :
 - l'inspection
 - la palpation
 - la percussion
 - l'auscultation
- les examens paracliniques (ou complémentaires) (radiographie, scanner, prise de sang, etc.).

5. Classification

Les signes cliniques sont les signes obtenus à l'examen clinique et on peut distinguer :

Les signes généraux :

Les signes généraux sont des signes très peu spécifiques : ils ne portent pas de caractéristique d'organe et sont communs à de nombreuses affections. Ils permettent d'évaluer l'état global du patient, et le retentissement de la maladie. Il s'agit de :

-l'asthénie : sensation de fatigue généralisée.

-l'anorexie : absence ou diminution de l'appétit. Ce signe ne doit pas être confondu avec l'anorexie mentale.

-l'amaigrissement : perte de poids supérieure ou égale à 5 % du poids habituel.

-la fièvre : augmentation de la température corporelle.

La combinaison de l'asthénie, de l'anorexie et de l'amaigrissement consiste en une altération de l'état général. Ces trois signes peuvent aussi bien être témoins d'une maladie somatique que d'une maladie psychiatrique, comme la dépression. On distingue plusieurs étiologies somatiques à une asthénie ou un amaigrissement : infectieuse ; cancer ; endocrinienne, par exemple le diabète ou l'hypothyroïdie ; neurologique ; hématologique, telle qu'une anémie ; digestive ; cardiovasculaire et respiratoire, comme une insuffisance cardiaque ; maladies systémiques ; troubles ioniques ou carences ; causes toxiques ou médicamenteuses.

Les signes fonctionnels :

Symptômes subjectifs, signes récupérés par l'interrogatoire, ressentis subjectivement par le malade, on peut citer la douleur, ou la dysphagie, correspondent à la plainte du malade, qui n'est pas toujours exprimée.

par ex : essoufflement, souffle court, manque d'air.. on les traduit en termes médicaux par le mot dyspnée, qui est une difficulté respiratoire.

Les signes physiques :

ceux qui sont obtenus à l'examen physique tel qu'une rougeur, un bruit anormal au stéthoscope, etc. recueillis sans instrument lourd sauf le stéthoscope, l'otoscope, l'ophtalmoscope, le thermomètre, le tensiomètre, le saturomètre, etc.

Sémiologie médicale par appareils :

- ✓ Sémiologie cardiovasculaire: Examen clinique cardiaque et vasculaire.
- ✓ Sémiologie pneumologique : Examen clinique pulmonaire ou respiratoire.
- ✓ Sémiologie de l'appareil digestif : Examen clinique de l'appareil digestif.
- ✓ Sémiologie neurologique : Examen clinique neurologique.

6. Syndrome et maladie

Le syndrome est un ensemble de signes ou de symptômes formant une entité bien définie mais pouvant avoir des causes multiples. Un syndrome n'est pas nécessairement équivalent à une maladie. Un syndrome (donc un ensemble de signes) peut être retrouvé dans plusieurs maladies. ex : syndrome méningé, syndrome néphrotique :

- albuminurie (= fuite de l'albumine dans les urines)
- baisse de l'albumine dans le sang (donc diminution de la pression osmotique)
- œdèmes (rétention d'eau)
- causes multiples : amylose, thrombose des veines rénales, glomérulonéphrite membraneuse.

Maladie = cause particulière d'un syndrome et de signes cliniques.

En fait la maladie est une construction intellectuelle :

- Constat de signes ou symptômes
- Regroupement en syndrome
- Reconnaissance d'une maladie

La construction peut être erronée (mauvais recueil des symptômes, erreur d'interprétation, méconnaissance de la maladie...)

7. Étiologie, pathogénie, physiopathologie

- Étiologie : c'est une science, c'est l'étude des causes des maladies (micro-organismes, ...)
- Pathogénie : mécanisme de la formation de la maladie
- Physiopathologie : distorsion de fonctionnement en cas de pathologie (dysfonctionnement au niveau moléculaire, cellulaire...).

8. Classification des maladies : Nosologie (nosos, maladie)

Maladies : infectieuses, cancéreuses, métaboliques, toxiques, génétiques, immunologiques... Parfois sans cause retrouvée = idiopathique, cryptogénique (kruptos, caché, genesis, genèse), primitive (à l'opposé de secondaire).

Ex : Ulcère de l'estomac. Avant on ne savait pas exactement ce qui en était la cause. C'était une hyperacidité gastrique qui le provoquait. Aujourd'hui, on sait que 80 à 90% des ulcères sont d'origine infectieuse en rapport avec une infection par un germe appelé helicobacter pylori. « l'ulcère est secondaire à une infection par helicobacter pylori »).

9. Sémiologie quantitative

La sémiologie quantitative est une branche de la sémiologie médicale, qui a pour rôle de quantifier la pertinence d'un signe clinique (sensibilité, spécificité, valeur prédictive positive, valeur prédictive négative et l'intégration de la valeur de plusieurs signes théorème de Bayes). Elle étudie la présence de la maladie / absence de la maladie, la présence d'un signe / absence d'un signe, dans le but d'établir un diagnostic le plus fiable possible.

La sémiologie quantitative a un rôle important dans le raisonnement médical. Par exemple, l'observation d'un signe pathognomonique, comme le signe de Koplik, donne avec certitude le diagnostic de rougeole. Ce type de signe a une valeur prédictive positive égale à un. En revanche, d'autres signes ne permettent pas de confirmer un diagnostic, même s'ils sont positifs : ils permettent seulement de l'infirmier s'ils sont négatifs. C'est par exemple le cas du dosage des Ddimères lors d'une suspicion d'embolie pulmonaire. Ce type de signe a une valeur prédictive positive faible.

10. L'importance de la sémiologie

C'est la première étape de l'exercice médical.

Analyse de l'histoire du malade et de la maladie obtenues par l'interrogatoire = 50% du diagnostic. (cela peut varier selon les spécialités : chez le rhumatologue, dans 80% des cas le diagnostic se fait à la fin de l'interrogatoire avant même d'avoir examiné physiquement le patient. Diagnostic évoqué qui se confirme ensuite par les examens physique et/ou complémentaires).

L'examen clinique contient l'interrogatoire et l'examen physique.

25% du diagnostic au cours de l'examen physique.

25% du diagnostic grâce aux examens complémentaires.

Acquisition d'une méthode pour :

- recueillir ces informations
- les traduire en langage médical

11. Comment apprendre la sémiologie ?

Sémantique : dictionnaire des termes techniques contient plus de 30000 occurrences sans être complet. On n'y arrive pas seul et pas seulement dans les livres ou les polyps !

Compagnonnage : les autres étudiants, les médecins mais aussi tout le personnel paramédical

Se documenter +++ (livres, CD-ROM, internet -site de l'UMVF - université médicale virtuelle francophone...)

12. Élaboration du diagnostic

- Recueil de données (interrogatoire, examen physique..)
- Traduction et le tri des informations. Cela demande une certaine expérience car il y a des infos apportées par le patient qui ne sont pas nécessairement utiles.
 - Traduire des symptômes souvent vagues en signes pertinents.
 - Séparer ce qui a une valeur sémiologique de ce qui est accessoire (nécessite une longue pratique)
- Intégration
 - Regrouper les signes en éventuels syndromes.
 - Évoquer des hypothèses diagnostiques.
 - Tester ces hypothèses par de nouvelles questions.
 - Autres recherches de signes d'examen.
 - Éventuellement demandes d'examens complémentaires.

13. Communication non verbale

Notre présentation n'est pas neutre. Les patients ont une certaine image des médecins.

Ne pas idéaliser le patient, ne pas le choquer sinon blocage dans la communication.

14. Dialogue avec le patient : 2 exigences

- ✓ Abord scientifique de la pathologie dont souffre le malade. Mener une enquête médicale.
- ✓ Établissement d'un contact humain visant dès le premier examen à gagner sa confiance, afin qu'il se livre. Il peut y avoir des choses dont il ne parle pas.

La communication : un art difficile

- ✓ Utiliser des questions facilement comprises par le patient. Utiliser le vocabulaire adéquat.
- ✓ Adapter le langage à la personne.
- ✓ Aborder les sujets les plus faciles à présenter.
- ✓ Observer (expressions faciales, corporelles).
- ✓ Écouter plus, parler moins et interrompre rarement.
- ✓ Plutôt quand, où, comment que pourquoi. Car le patient vient chercher la réponse au pourquoi.

Références bibliographiques

https://psychanalyse.com/pdf/MEDECINE_SEMIOLOGIE_APPRENTISAGE.pdf

<https://www.livres-medicaux.com/3709-semiologie>

<https://www.youtube.com/watch?v=0c1RPaiWzoM>

https://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9miologie_m%C3%A9dicale

<https://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9mantique>